



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
UNIT LAUNDRY**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Unit Laundry

Disusun oleh :
Penanggung Jawab Unit Laundry



(**Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep**)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP**)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**dr. Nur Mazidah**)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan pedoman pelayanan unit laundry Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pelayanan unit laundry RS Prima Husada Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi kegiatan pelayanan yang dilakukan di unit laundry Rumah Sakit Prima Husada.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan pedoman ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku pedoman ini.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PELAYANAN UNIT LAUNDRY

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
3. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
4. Putri Indah P, A.Md.Keb
5. Tri Ani Darma, A.Md.Kep
6. Laras Wieny Nuriska, A.Md.Kep
7. Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep
8. Umi Kulsum
9. Nur Hidayat
10. Salma Taris Mafula
11. Hamzah Zulfiqar Jonas
12. Davit Krisdianto

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABELvii

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADAviii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Pedoman..... 1

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan 1

1.4 Batasan Operasional..... 2

BAB II 3

STANDAR KETENAGAAN 3

2.1 Kualifikasi Sumber Daya manusia 3

2.2 Distribusi Ketenagaan 3

2.3 Pengaturan Jaga..... 3

BAB III..... 4

STANDAR FASILITAS 4

3.1 Denah Ruang..... 4

3.2 Standar Fasilitas 4

BAB IV 7

TATA LAKSANA PELAYANAN 7

4.1 Perencanaan Linen 7

4.2 Penatalaksanaan Linen..... 9

BAB V 14

LOGISTIK 14

BAB VI 15

KESELAMATAN PASIEN DAN PETUGAS..... 15

BAB VII 16

KESELAMATAN KERJA 16

BAB VIII 22

PENGENDALIAN MUTU 22

BAB IX 23

PENUTUP 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Denah Ruang
Gambar 4.1	Alur Tata Laksana Unit Laundry

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kualifikasi Tenaga Unit Laundry
Tabel 2.2	Pola Ketenagaan Unit Laundry
Tabel 2.3	Distribusi Ketenagaan
Tabel 2.4	Pengaturan Jaga



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UNIT LAUNDRY

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap instalasi pelayanan yang ada;
- b. bahwa agar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan pemberlakuan buku Pedoman Pelayanan Laundry;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT LAUNDRY RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA.**



Pasal 1

- (1) Pelayanan laundry rumah sakit dimulai dari unit-unit terkait seperti instalasi rawat inap, instalasi kamar operasi sampai instalasi rawat jalan.
- (2) Pelayanan dimulai dari pengambilan linen kotor dari unit-unit oleh petugas laundry.

Pasal 2

- (1) Pengambilan linen kotor dilakukan oleh petugas laundry pada waktu yang tidak bersamaan dengan pembagian makan pasien.
- (2) Pendistribusian linen bersih dilakukan setiap hari dengan system FIFO.

Pasal 3

- (1) Linen khusus kamar operasi segera dikirim ke unit sterilisasi bila sudah dicuci dan siap pakai agar tidak kehabisan linen apabila ada operasi.

Pasal 4

Pemeliharaan linen rusak :

- (1) Yang masih dapat diperbaiki di bawa ke pihak ke tiga agar bisa diperbaiki.
- (2) Yang tidak dapat diperbaiki dilakukan pemusnahan.

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan peralatan yang rusak di laundry dilaporkan ke IPSRS bila tidak bisa dibetulkan dilakukan permintaan perbaikan ke pihak ke tiga.
- (2) Permintaan chemical dilakukan sebelum stok di laundry habis.
- (3) APD dan fasilitas kebersihan tangan tersedia dan digunakan sesuai prosedur oleh petugas.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKITPRIMA HUSADA
NOMOR 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
UNIT LAUNDRY

PEDOMAN PELAYANAN UNIT LAUNDRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi bagi pasien dan petugas rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit. Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka perlu dilakukan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit adalah melalui pelayanan penunjang medik, khususnya dalam pengelolaan linen di rumah sakit. Linen di rumah sakit dibutuhkan di setiap ruangan. Kebutuhan akan linen di setiap ruangan ini sangat bervariasi, baik jenis, jumlah dan kondisinya. Alur pengelolaan linen cukup panjang, membutuhkan pengelolaan khusus dan banyak melibatkan tenaga kesehatan dengan bermacam-macam klasifikasi. Klasifikasi tersebut terdiri dari ahli manajemen, teknisi, perawat, tukang cuci, penjahit, tukang setrika, ahli sanitasi, serta ahli kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk mendapatkan kualitas linen yang baik, nyaman dan siap pakai, diperlukan perhatian khusus, seperti kemungkinan terjadinya pencemaran infeksi dan efek penggunaan bahan-bahan kimia.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan mutu pelayanan linen di rumah sakit

2. Tujuan Khusus

- a. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan linen di rumah sakit.
- b. Sebagai pedoman kerja untuk mendapatkan linen yang bersih, kering, rapi, utuh dan siap pakai.
- c. Sebagai panduan dalam meminimalisasi kemungkinan untuk terjadinya infeksi silang.
- d. Untuk menjamin tenaga kesehatan, pengunjung, kontraktor dan lingkungan dari terpaparnya bahaya potensial.
- e. Untuk menjamin ketersediaan linen di setiap unit di rumah sakit.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Laundry Rumah Sakit prima Husada memberikan pelayanan dan pengelolaan linen untuk kebutuhan pelayanan rumah sakit di semua unit yang terkait.

1.4 Batasan Operasional

Instalasi laundry Rumah Sakit Prima Husada merupakan salah satu instalasi penunjang pelayanan yang berperan dalam pengelolaan linen di rumah sakit. Batasan operasional dari instalasi laundry mencakup proses:

1. Pengelolaan linen infeksius
Linen yang terpapar cairan tubuh pasien
2. Pengelolaan linen non infeksius
Linen kotor berasal dari ruang perawatan, unit/bagian yang ada di Rumah Sakit.

Kebijakan Pelayanan:

1. Pelayanan laundry rumah sakit dimulai dari unit-unit terkait seperti instalasi rawat inap, instalasi kamar operasi sampai instalasi rawat jalan
2. Pelayanan dimulai dari pengambilan linen kotor dari unit-unit oleh petugas laundry.
3. Pengambilan linen kotor dilakukan pukul 13.00 wib tidak boleh bersamaan dengan pembagian makan pasien.
4. Pendistribusian linen bersih dilakukan setiap hari dengan system FIFO.
5. Linen khusus IKO segera di kirim ke instalasi sterilisasi bila sudah dicuci dan siap pakai agar tidak kehabisan linen apabila ada operasi.
6. Baju operasi yang selesai di cuci segera didistribusikan ke instalasi kamar operasi.
7. Petugas laundry menggantikan petugas kebersihan IKO yang libur di hari sabtu-minggu apabila ada operasi.
8. Pemeliharaan linen rusak :
 - Yang masih dapat diperbaiki dibawa ke pihak ketiga agar bisa di perbaiki.
 - Yang tidak dapat diperbaiki dilakukan pemusnahan.
9. Pemeliharaan peralatan yang rusak di laundry dilaporkan ke IPSRS bila tidak bisa dibetulkan dilakukan permintaan perbaikan ke pihak ketiga.
10. Permintaan chemical dilakukan sebelum stock dilaundry habis.
11. Pencucian mukena masjid "Baiturrahim" dilakukan setiap hari Senin dan Kamis.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya manusia

- 1. Kualifikasi tenaga :
 - a. Ka. Sub. Unit Laundry : D3 sederajat
 - b. Tenaga non medis : minimal pendidikan SMU

Nama Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan
Ka. Sub. Unit Laundry	Minimal D3	Pengalaman kerja minimal 5	1
Tenaga non medis	Minimal SMU	Pelatihan internal Minimal kerja 2tahun	5

Tabel 2.1 kualifikasi Tenaga Unit Laundry

2. Pola Ketenagaan Laundry

No	Jenis Pendidikan	Pendidikan/Sertifikasi	Jumlah Tenaga
1.	Ka. Sub. Unit Laundry	Minimal D3	1
2.	Tenaga non medis	Minimal SMU	5

Tabel 2.2 Pola Ketenagaan Unit Laundry

2.2 Distribusi Ketenagaan

No	Jabatan	Fungsi
1.	Ka. Sub. Unit Laundry	Manajerial (mengikuti jam dinas)
2.	Tenaga non medis	Tenaga laundry

Tabel 2.3 Distribusi Ketenagaan

2.3 Pengaturan Jaga

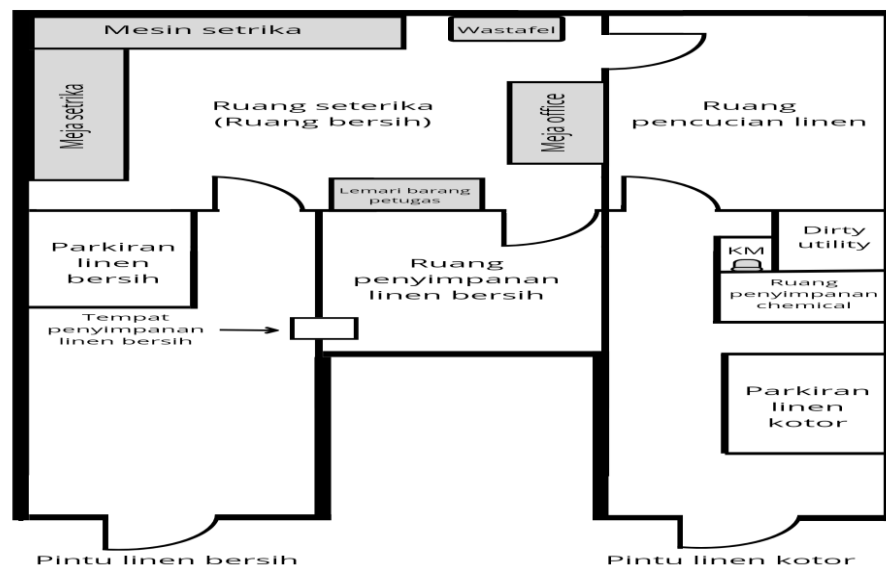
No	Jabatan	Fungsi	Jadwal kerja
1.	Ka. Sub. Unit Laundry	Manajerial (mengikuti jam dinas)	Senin-Sabtu Jam 06.30-14.00
2.	Tenaga non medis	Tenaga laundry	Sesuai dengan jadwal

Tabel 2.4 Pengaturan Jaga

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang



Gambar 3.1 Denah Ruang

3.2 Standar Fasilitas

1. Fasilitas fisik

✓ Bangunan

Bangunan untuk instalasi pencucian mempunyai persyaratan tersendiri, terutama untuk pemasangan peralatan pencucian yang baru. Sebelum pemasangan, data lengkap SPA (sarana, prasarana, alat) diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan jejaring selama pengoperasiannya. Tata letak dan hubungan antar ruangan memerlukan perencanaan teknik yang matang, untuk memudahkan penginstalasian termasuk instalasi listrik, uap, air panas dan penunjang lainnya. Sarana fisik instalasi pencucian terdiri beberapa ruang antara lain:

a. Ruang penerimaan linen

Ruangan ini memuat:

- 1) Meja penerima yaitu untuk linen yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Linen yang diterima harus sudah terpisah, kantung yang kuning untuk yang terinfeksi dan kantung warna putih untuk yang tidak terinfeksi.
- 2) Timbangan duduk
- 3) Ruang yang cukup untuk troli pembawa linen kotor untuk dilakukan desinfeksi sesuai standart sanitasi Rumah Sakit.

Sirkulasi udara perlu diperhatikan dengan memasang fan atau exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan C = 100-200 Lux sesuai pedoman pencahayaan Rumah Sakit.

b. Ruang pemisahan linen

Ruang ini memuat meja panjang untuk mensortir jenis linen yang tidak terinfeksi. Sirkulasi udara perlu diperhatikan dengan memasang fan atau exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan D = 200-500 Lux sesuai pedoman pencahayaan Rumah Sakit, Lantai dalam ruang ini tidak boleh dari bahan yang licin.

c. Ruang pencucian dan pengeringan linen

Ruang ini memuat:

- 1) Mesin cuci
- 2) Mesin pengering

Lantai dalam ruang ini tidak dibuat dari bahan yang licin dan diperhatikan kemiringannya. Jika rumah sakit sudah menggunakan mesin cuci otomatis maka daya listrik yang diperlukan antara 4,8-5Kva. Petunjuk penggunaan mesin cuci harus selalu berada dekat mesin cuci tersebut agar petugas operator selalu bekerja sesuai prosedur. Sirkulasi udara perlu diperhatikan dengan memasang exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan C = 100-200 Lux sesuai pedoman Pencahayaan Rumah Sakit.

d. Ruang penyetrikaan linen

Ruang ini memuat:

Meja penyetrikaan linen menggunakan alat setrika biasa yang menggunakan listrik sekitar 200va. Sirkulasi udara perlu diperhatikan dengan memasang fan dan exhaust fan untuk penerangan minimal kategori pencahayaan D = 200-500 Lux sesuai pedoman Pencahayaan Rumah Sakit.

e. Ruang penyimpanan linen

Ruang ini memuat:

- 1) Lemari dan rak menyimpan linen
- 2) Meja administrasi

Ruang ini bebas dari debu dan pintu selalu tertutup. Sirkulasi udara dipertahankan tetap baik dengan memasang fan / exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan D = 200-500 Lux sesuai pedoman Pencahayaan Rumah Sakit, suhu 22-27°C dan kelembaban 45-75% RH.

✓ Peralatan dan bahan pencuci

Peralatan pada instalasi pencucian menggunakan bahan pencuci kimiawi dengan komposisi dan kadar tertentu, agar tidak merusak bahan yang dicuci/linen, mesin cuci, kulit petugas yang melaksanakan dan limbah buangnya tidak merusak lingkungan. Peralatan pada instalasi pencucian antara lain :

1. Mesin cuci / washing machine
2. Mesin pengering / drying tumbler
3. Mesin penyetrika / flatwork ironer

a. Produk bahan kimia

Proses kimiawi akan berfungsi dengan baik apabila 3 faktor di atas bereaksi dengan baik. Menggunakan bahan kimia berlebihan tidak akan membuat hasil lebih baik, begitu juga apabila kekurangan. Bahan kimia yang dipakai secara umum terdiri dari :

1. Alkali

Mempunyai peran meningkatkan fungsi atau peran detergen dan emulsifier serta membuka pori dari linen.

2. Detergen = sabun pencuci

Mempunyai peran menghilangkan kotoran yang bersifat asam secara global

3. Emulsifier

Mempunyai peran untuk mengemulsi kotoran yang berbentuk minyak dan lemak

4. Bleach = pemutih

Mengangkat kotoran / noda, mencemerlangkan linen, dan bertindak

sebagai desinfektan , baik pada linen yang berwarna (ozone) dan yang putih (chlorine).

5. Sour / penetral

Menetralkan sisa dari bahan kimia pemutih sehingga pH-nya menjadi 7 atau netral.

6. Softener

Melembutkan linen .digunakan pada proses akhir pencucian.

7. Pemutih

Digunakan pada proses pencucian linen warna putih yang berfungsi memecah noda kotoran,darah atau minyak

✓ Pemeliharaan ringan peralatan

Alat cuci pada instalasi pencucian dijalankan oleh para operator alat, dengan demikian para operator alat harus memelihara peralatannya.Berbagai kelainan pada saat pengoperasiannya , misalnya kelainan bunyi pada alat dapat segera dikenali oleh para operator.Pemeliharaan ringan peralatan pencucian terdiri dari:

1. Pembersihan peralatan sebelum dan sesudah pemakaian.

Dilakukan setiap hari dengan menggunakan lap basah dicampur dengan bahan kimia MPC (Multi Purpose Cleaner) dan dikeringkan dengan lap kering.Untuk baagian tombol/control digunakan lap kering dan jangan terlalu ditekan,dikarenakan pada bagian ini biasanya tertulis prosedur dengan semacam stiker yang mudah terhapus. Setelah pemakaian, kosongkan air untuk mengurangi kandungan air dalam mesin sekecil mungkin.Jika terbentuk noda putih didalam mesin cuci, cucilah bagian dalam drum dengan air bersih.

2. Pemeriksaan bagian bagian dalam yang bergerak

Dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu pada bearing, engsel pintu alat atau roda yang berputar.Berilah minyak pelumas atau fat/gemuk. Penggantian gemuk/fat secara total disarankan dua tahun sekali. Jenis dan produk minyak pelumas mesin yang digunakan dapat diketahui dari buku Operating Manual setiap mesin.Buku ini selalu menyertai peralatan pada saat penerimaan barang.

3. Pemeriksaan V-belt

Dilakukan setiap satu bulan yakni secara visual dengan melihat keretakan lempeng V-belt, dan dengan perabaan untuk menilai kehalusan V-belt dan keteganganya (kelenturan), toleransi pengukuran 0,2-0,5 mm.Jika melebihi atau sudah tidakmemenuhi syarat V-belt tersebut segera diganti.

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Perencanaan Linen

a. Sentralisasi Linen

Sentralisasi merupakan suatu keharusan yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, dimana merupakan suatu siklus berputar. Sifat linen adalah barang habis pakai. Supaya terpenuhi persyaratan mutlak yaitu kondisi yang selalu siap baik segi kualitas maupun kuantitas, maka diperlukan sistem pengadaan satu pintu yang sudah terprogram dengan baik. Untuk itu diperlukan kesepakatan-kesepakatan baku dan merupakan suatu kebijakan yang turun dari pihak top level *management* yang kemudian di aplikasikan menjadi suatu standart yang harus dijalankan dan dilaksanakan dengan prosedur tetap (protap) dan petunjuk teknis (juknis) yang selalu dievaluasi.

b. Standarisasi Linen

Linen adalah istilah untuk menyebutkan seluruh produk tekstil yang berada di rumah sakit yang meliputi linen di ruang perawatan maupun baju bedah di ruang operasi (OK), sedangkan baju perawat, jas dokter maupun baju kerja biasanya tidak di kelompokkan pada kategori linen, tetapi dikategorikan sebagai seragam (*uniform*). Secara fungsional linen digunakan untuk baju, alas, pembungkus, lap, dan sebagainya, sehingga dalam perkembangan *manajemennya* menjadi tadaksederhana lagi, berhubung tiap bagian di rumah sakit mempunyai spesifikasi pekerjaan, jumlah kebutuhan yang besar, frekuensi cuci yang tinggi, keterbatasan persediaan, penggunaa yang majemuk dan *image* yang ingin dicapai. Untuk itu diperlukan standard linen , anatara lain :

1. Standard Produk

Berhubung sarana kesehatan bersifat universal, maka sebaiknya setiap rumah sakit mempunyai standard produk yang sama, agar bisa diproduksi massal dan mencapai segala ekonomi. Produk dengan kualitas tinggi akan memberikan kenyamanan pada waktu pemakaiannya dan mempunyai waktu penggunaan yang lebih lama, sehingga secara ekonomi lebih optimum dibandingkan dengan produk yang lebih murah.

2. Standard Desain

Pada dasarnya baju rumah sakit lebih mementingkan fungsinya dari pada estetikanya, maka desain yang sederhana, ergonomis merupakan pilihan yang ideal, terutama pada baju bedah dan baju pasien. *Sizing System* dengan pembedaan warna, di aplikasikan pada baju- baju tertentu untuk mengakomodasikan individu pemakai. Untuk kepentingan praktis. Beberapa rumah sakit menggunakan seprei/ laken yang *fitted* selain yang flat. Yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan pada waktu pemeliharaan, penggunaan kancing dan sambungan-sambungan baju lebih baik dihindari.

c. Standard Material

Pemilihan material harus disesuaikan dengan fungsi, cara perawatan dan penampilan yang diharapkan. Beberapa kain yang digunakan di rumah sakit antara lain cotton 100%, CVC 50% -50%, TC 65%-35%, Polyester 100% dengan anyaman plat atau *twill/drill* dengan proses akhir yang lebih spesifik, seperti : *water repellent, soil release, PU coated* dan sebagainya yang mempunyai sifat dan penggunaan-penggunaan tertentu. Dengan adanya berbagai pilihan tersebut memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan hasil terbaik untuk setiap produk. Warna pada kain/ baju juga memberikan nuansa tersendiri, sehingga secara psikologis mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu,

pemilihan warna sangat penting. Alternatif dari kain warna yang polos adalah dengan kain corak motif, tren ini memberikan nuansa yang lebih santai dan modern.

1. Standard Ukuran

Ukuran linen sebaiknya di pertimbangkan tidak hanya dari sisi penggunaan, tetapi juga dari biaya pengadaan dan biaya operasional yang timbul. Makin luas dan berat, makin mahal biaya pengadaan dan pengoperasional. Dengan adanya ukuran tempat tidur yang standart, misalnya : 90x200cm, maka ukuran linen bisa di standartkan menjadi :

- Laken 160x275 cm
- Steek laken 75x160 cm
- Zeil 70x110 cm
- Sarung bantal 50x70 cm

2. Standard jumlah

Dealnya jumlah stok linen 5 par (kapasitas) dengan posisi 3 par berputar diruangan : stok 1 par terpakai, stok 1 par dicuci, stok 1 par cadangan dan 2 par mengendap di logistik :1 par sudah terjat dan 1 par berupa lembaran kain.

3. Standart Penggunaan

Linen yang baik seharusnya tahan cuci samapai 350x dengan prosedur normal. Sebaiknya setiap rumah sakit menentukan standart kelayakan sebuah linen, apakah dengan umur linen, kondisi fisik atau dengan frekuensi cuci.

d. Mesin Cuci

Persyaratan mesin cuci :

1. Mesin cuci dengan kapasitas besar (diatas 100kg) yang disarankan memiliki 2 kompartemen (pintu) yang membedakan antara memasukan linen kotor infeksius/non infeksius dengan hasil pencucian linen bersih. Antara 2 kompartemen di batasi oleh pertisi yang kedap air. Maksud dari pemisahan tersebut adalah menghindari kontaminasi dari linen kotor dengan linen bersih baik dari lantai, alat maupun udara.
2. Mesin cuci ukuran sedang dan kecil (25-100kg) tanpa penyekat seperti pada point 1 dapat digunakan dengan memperhatikan batas ruang kotor dan bersih dengan jelas.
3. Pipa pembuangan limbah cair hasil pencucian (pemanasan-desinfeksi) langsung dialirkan kedalam system pembuangan yang terpendam dalam tanah menuju IPAL.
4. Peralatan pendukung yang mutlak digunakan untuk membantu proses pemanasan-desinfeksi :
 - Pencatat suhu (termometer) pada mesin cuci.
 - Termostaat untuk membantu meningkatkan suhu pada mesin cuci
 - Glass/kaca untuk melihat level air.
 - *Flow meter* pada inlet air bersih ke mesin cuci untuk mengukur jumlah air yang dibutuhkan pada saat pengenceran bahan kimia terutama pada saat desinfeksi.

e. Tenaga laundry

Untuk mencegah infeksi yang terjadi di dalam pelaksanaan kerja terhadap tenaga pencuci maka perlu ada pencegahan dengan :

- Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala.
- Pemberian imunisasi poliomyelitis, tetanus, BCG dan hepatitis
- Pekerja yang memiliki permasalahan dengan kulit : luka-luka, ruam, kondisi kulit eksfoliatif tidak boleh melakukan pencucian.

4.2 Penatalaksanaan Linen

Penatalaksanaan linen dibedakan menurut lokasi dan kemungkinan transmisi organisme berpindah :

1. Di ruangan-ruangan
2. Perjalanan transportasi linen kotor
3. Pencucian di laundry
4. Penyimpanan linen bersih
5. Distribusi linen bersih

Linen kotor yang dapat dicuci di laundry dikategorikan :

1. Linen kotor infeksius : linen yang terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh dan feses terutama yang berasal dari infeksi TB paru, infeksi *salmonella* dan *shigella* (sekresi dan eksresi), HBV dan HIV (jika terdapat noda darah) dan infeksi lainnya yang spesifik (SARS) dimasukan kedalam kantung dengan segel yang dapat terlarut di air dan kembali ditutup dengan kantung luar berwarna kuning bertuliskanterinfeksi.
2. Linen kotor tidak terinfeksi : linen yang tidak terkontaminasi darah, cairan tubuh dan feses yang berasal dari pasien lainnya secara rutin sungguh pun mungkin linen yang di klasifikasikan dari seluruh pasien-pasien yang berasal dari sumber ruang isolasi yang terinfeksi.

Linen atau pakaian pasien yang terinfeksi bahaya khusus seperti *lassa fever* atau antrax sebaiknya dilakukan autoklaf sebelum dirim ke laundry atau konsultasikan dengan bagian yang menangani infeksi. Untuk lebih terperinci penanganan linen dibedakan denga lokasi sebagai berikut :

1. Pengelolaan linen di ruangan

Seperti disebutkan di atas yang dimaksud dengan linen infeksius dan non infeksius yang secara spesifik di perlakukan secara khusus dengan kantung linen yang berbeda. Persyaratan kantung linen pada ruangan :

a) Kantung linen infeksius (dapat dipakai ulang).kantung linen infeksius terdiri dari dua kantong yang memiliki criteria :

- Kantung dalam
 - ✓ Terbuat dari bahan plastik tahan panas hingga 100°C dan tahan bocor
 - ✓ Bentuk segi empat dengan bagian yang terbuka merupakan panjang kantung
 - ✓ Warna bening
 - ✓ Ukuran kecil hingga sedang
- Kantung luar (dapat dipakai ulang)
 - ✓ Terbuat dari bahan plastik tahan panas hingga 100°C dan tahan bocor
 - ✓ Bentuk segi empat
 - ✓ Warna kuning bertuliskan linen infeksius.
 - ✓ Ukuran sedang hingga besar

b) Kantung linen non infeksius(dapat dipakai ulang)

- Terbuat dari bahan plastik tahan panas hingga 100°C dan tahan bocor.
- Bentuk segi empat
- Warna putih bertuliskan linen kotor tidak terinfeksi
- Ukuran sedang hingga besar

Penanganan linen di mulai dari proses verbeden (penggantian linen). Pelaksanaan verbeden dilakukan oleh perawat dimana sebelum dilakukan penggantian linen bersih harus melepaskan linen kotor dengan demikian perawat tersebut akan kontak dengan linen kotor baik itu dengan linen kotor infeksius maupun tidak terinfeksi. Prosedur untuk linen kotor infeksius :

- a. Biasakan mencuci tangan hygienis dengan sabun paling tidak 10-15 detik

sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.

- b. Gunakan APD : sarung tangan, masker, dan apron.
- c. Persiapkan alat : kantung plastic linen infeksius warna kuning.
- d. Lipat bagian yang terinfeksi di bagian dalam lalu masukkan linen kotor infeksius kedalam kantung plastik warna kuning dan bawa ke tempat linen kotor infeksius di unit perawatan.
- e. Linen kotor infeksius di unit perawatan siap di ambil petugas laundry untuk di lakukan proses pencucian.

Prosedur untuk linen tidak terinfeksi :

- a. Biasakan mencuci tangan hygienis dengan sabun paling tidak 10-15 detik sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.
- b. Gunakan APD : sarung tangan masker dan apron.
- c. Persiapkan alat : kantung plastic linen non infeksius warna putih
- d. Lipat bagian yang terkena noda di bagian dalam lalu masukkan linen kotor non infeksius ke dalam kantung plastik dan bawa ke tempat linen kotor non infeksius di unit perawatan.
- e. Linen kotor non infeksius di unit perawatan siap diambil petugas laundry untuk dilakukan proses pencucian.

2. Transportasi

Transportasi dapat merupakan bahaya potensial dalam menyebarkan organism , jika linen kotor tidak tertutup dan bahan troli tidak mudah dibersihkan.

Persyaratan alat transportasi linen :

- Dipisahkan antara troli linen kotor dengan linen bersih, jika tidak makawadah penampung yang terpisah.
- Bahan troli terbuat dari stainless steel (baja anti karat).
- Jika menggunakan wadah dan warna yang berbeda.
- Wadah mampu menampung beban linen.
- Wadah mudah dilepas dan setiap saat habis difungsikan selalu dicuci (siapkan cadangan) demikian pula dengan trolinya selalu dibersihkan.
- Muatan / loading linen kotor / bersih tidak berlebihan.
- Wadah memiliki tutup.

3. Laundry

Tahapan kerja di laundry :

- a. Pengambilan linen kotor dengan prosedur pencatatan
Linen kotor yang berasal dari ruangan dicatat berat timbangan sedangkan jumlah satuan berasal dari informasi runangan dengan formulir yang sudahdi stardardkan. Tidak dilakukan pembongkaran muatan untuk mencegah penyebaran organisme.
- b. Pemilahan dan penimbangan linen kotor
 - 1) Dilakukan pemilahan berdasarkan beberapa kriteria :
 - Linen infeksius berwarna.
 - Linen infeksius putih.
 - Linen non infeksius berwarna.
 - Linen non infeksius putih.
 - Linen asal kamar operasi
 - 2) Upayakan tidak melakukan pensortiran. Pensortiran untuk linen infeksius sangat tidak dianjurkan, penggunaan kantung sejak dari ruangan adalah salah satu upaya menghindari sortir.
 - 3) Penimbangan sesuai dengan kapasitas dan kriteria dari point b, dimaksudkan untuk menghitung kebutuhan bahan-bahan kimia dalam tahapan proses pencucian.
- c. Pencucian
Pencucian mempunyai tujuan selain menghilangkan noda (bersih), awet

(tidak cepat rapuh), namun memenuhi persyaratan sehat (bebas dari mikroorganisme patogen). Sebelum melakukan pencucian setiap harinya, lakukan pemanasan sampai desinfeksi untuk membunuh seluruh mikroorganisme yang mungkin tumbuh dalam semalam di mesin-mesin cuci. Untuk dapat mencapai tujuan pencucian, harus mengikuti persyaratan teknis pencucian :

1) Waktu

Waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan temperatur dan bahan kimia guna mencapai hasil cucian yang bersih, sehat. Jika waktu tidak tercapai sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka kerja bahan kimia tidak berhasil dan yang terpenting mikroorganisme dan jenis pests seperti kutu dan tungau dapat mati.

2) Suhu

Suhu yang direkomendasikan untuk tekstil : katun $\leq 90^{\circ}\text{C}$, polykatun $\leq 80^{\circ}\text{C}$, polyester $\leq 75^{\circ}\text{C}$, wool dan silk $\leq 30^{\circ}\text{C}$. sedangkan suhu terkait dengan pencampuran bahan kimia dan proses :

- Proses *prewash* dengan tanpa/bahan kimia dengan suhu normal
- Proses cuci dengan bahan kimia alkali dan detergen untuk linen warna putih $45-50^{\circ}\text{C}$, untuk linen warna $60-80^{\circ}\text{C}$.
- Proses *bleaching* atau dilakukan desinfeksi 65°C atau 71°C
- Proses bilas I dan II dengan suhu normal
- Proses penetralan dengan suhu normal
- Proses pelembut dengan suhu normal

3) Bahan kimia

Bahan kimia yang digunakan terdiri dari : alkali, emulsifier, detergen, bleach (chlorine bleach dan oksigen bleach), sour, softener, dan starch. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Penanganan linen infeksius dipersyaratkan menggunakan bahan kimia chlorine formulasi 1%.

4) Mekanikal action

Mekanikal action adalah putaran mesin pada saat proses pencucian. Factor-faktor yang mempengaruhi mekanikal action adalah :

- Loading/muatan tidak sesuai dengan kapasitas mesin. Mesin harus dikosongkan 25% dari kapasitas mesin. Sebagai contoh : kapasitas mesin 50 kg, maka loading/beban yang dimasukan tidak boleh $\leq 37,5$ kg
- Level air yang tidak tepat
Level air adalah jumlah air yang diperlukan untuk pengencer bahan kimia yang terdiri dari level : TINGGI = 50% dari kapasitas drum, SEDANG = 32% dari kapasitas drum, dan RENDAH = 16,6% dari kapasitas drum.
- Motor penggerak yang tidak stabil
- Motor penggerak tidak stabil dapat disebabkan poros yang tidak simetris lagi dan automatic refresh yang tidak bekerja. Pemeliharaan yang continue tidak akan membiarkan kondisi ini terjadi, karena selain hasil cucian tidak maksimal, juga dapat merambat kerusakan pada komponen lainnya.
- Takaran detergen yang berlebihan
- Takaran detergent yang berlebihan mengakibatkan melicinkan linen dan busa yang berlebihan akan mengakibatkan sedikit gesekan.

5) Bahan kimia

Bahan kimia akan berfungsi dengan baik apabila 3 faktor tersebut diatas berfungsi dengan baik. Menggunakan bahan kimia yang berlebihan tidak akan membuat hasil menjadi lebih baik, begitu juga apabila terjadi kekurangan.

- d. Pengeringan
Pengeringan dilakukan dengan mesin pengering/*drying* yang mempunyai suhu sampai dengan 70°C selama 10 menit. Pada proses ini, jika mikroorganisme yang belum mati atau terjadi kontaminasi ulang diharapkan dapat mati
- e. Penyetrikaan
Penyetrikaan dapat dilakukan dengan mesin setrika besar dapat disetel sampai dengan suhu sampai dengan 120°C, namun harus diingat bahwa linen mempunyai keterbatasan terhadap suhu sehingga suhu disetel antara 70-80°C.
- f. Pelipatan
Melipat linen mempunyai tujuan selain kerapian juga mudah digunakan pada saat penggantian linen dimana tempat tidur kosong atau saat pasien diatas tempat tidur. Linen yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pelipatan :
 - 1) Laken/ spreii.
 - 2) Steek laken
 - 3) Zeil
 - 4) Sarung bantal
 - 5) Selimut
- g. Penyimpanan
Penyimpanan mempunyai tujuan selain melindungi linen dari kontaminasi ulang baik dari bahaya seperti mikroorganisme dan pest, juga untuk mengontrol posisi linen tetap stabil. Sebaiknya posisi linen yang terdapat di ruang penyimpanan 1,5 par dan 1,5 par di ruangan-ruangan. Ada baiknya lemari penyimpanan di pisahkan menurut masing-masing ruangan dan diberi obat anti ngengat yaitu kapur barus. Sebelum disimpan sebaiknya linen dibungkus dengan plastic transparan, sebelum didistribusikan.
- h. Pendistribusian
Pendistribusian merupakan aspek administrasi yang penting yaitu pencatatan linen yang keluar. Di sini diterapkan system FIFO yaitu linen yang tersimpan sebelumnya yaitu : 1,5 par yang mengendapdi penyimpanan harus dikeluarkan, sedangkan yang selesai dicuci disiapkan untuk yang berikutnya, sehingga tidak ada pekerja yang menunggu setiap selesai mencuci. Ada baiknya bagian inventaris ruangan pada saat yang bersamaan linen yang dicuci di tujkar dengan linen bersih yang siap didistribusikan. Sedangkan linen sisa yang berada di ruangan harus disiapkan untuk digunakan kembali. Setiap linen yang dikeluarkan dicatat sesuai identitas yang tertera di setiap linen, nomer berapa yang keluar dan nomer berapa yang disimpan, dengan pencatatan tersebut dapat diketahui berapa kali linen dicuci dan linen mana saja yang mengendap tidak digunakan.
- i. Penggantian linen rusak
Linen rusak dapat dikategorikan :
 - 1. Umur linen sudah standard
 - 2. Human error termasuk dihilangkanDua kategori tersebut dapat diketahui dari system pencatatan yang baik mengenai perputaran linen yang tercatat setiap harinya bahkan dapat diketahui ruangan yang menghilangkan atau merusak, namun dapat juga kerusakan terjadi pada waktu proses pencucian akibat human error petugas laundry.
Jenis kerusakan ada yang dapat diperbaiki (diserahkan ke penjahit) dan ada pula yang harus mendapatkan penggantian. Jenis kerusakan yang harus mendapatkan penggantian :
 - Moda-noda yang sudah tidak dapat dihilangkan seperti terkena cairan

medik dengan area yang luas ataupun terkena noda semir, mungkin dapat dihilangkan dengan cairan spoting namun jika dihitung biaya dan kerapuhan yang terjadi menjadi tidak efisien.

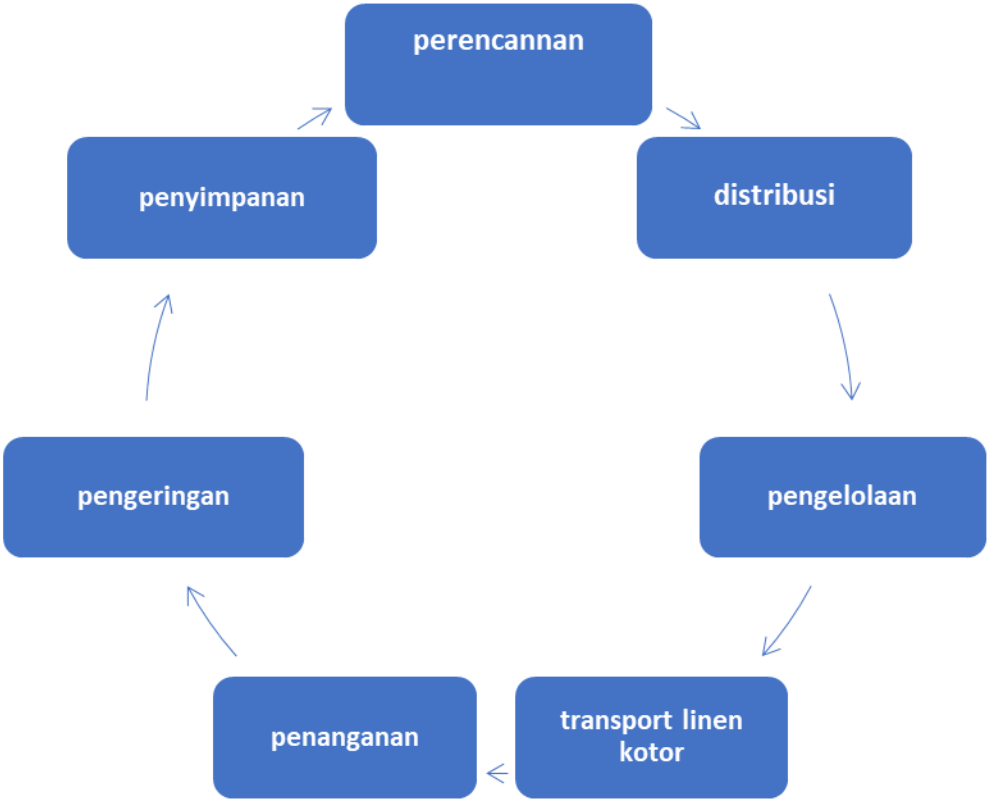
- Kerapuhan beberapa bagian akibat bahan kimia korosif seperti H₂O₂ ataupun bahan kimia lainnya yang korosif seperti peroksida maupun chlorine diatas 5%.
- Robek karena tersangkut

Pada saat proses pengambilan sampai penyetrikaan merupakan proses yang krusial dimana kemungkinan organism masih hidup, maka petugas diwajibkan menggunakan APD. Alat pelindung diri yang digunakan petugas laundry :

- Pakaian kerja dari bahan yang menyerap keringat
- Apron
- Sarung tangan
- Sepatu boot digunakan paada area yang basah
- Masker digunakan pada proses pemilahan dan sortir

Sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan biasakan mencuci tangan , sebagai upaya pertahanan diri.

Gambar 4.1 Alur Tata Laksana Unit Laundry



BAB V

LOGISTIK

Tabel 5.1 Peralatan Unit Laundry

No	Nama Barang
1	Mesin cuci
2	Mesin pengering
3	Chemical: Alkali Emulsi Oxygen bleachBleach Penetral Soft
4	Alat Rumah Tangga: Pelicin pakaianDetergent Sikat cuci Pelembut dan pewangiSepatu boot Alat setrika Meja setrika Lemari linen bersihKeranjang linen Rak chemical Sarung tangan
5	Troli: Troli linen kotor infeksius Troli linen kotor non infeksiusTroli linen bersih / distribusi

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN DAN PETUGAS

6.1 Pengertian

Keselamatan Pasien / *Patient Safety* adalah keadaan dimana pasien bebas dari *harm* atau cedera, yang dapat meliputi penyakit, cedera fisik, psikologis, sosial, penderitaan, cacat, kematian dan lainnya, yang seharusnya tidak terjadi.

Di Laundry, Keselamatan Pasien bertartu semua standar prosedur operasional yang sudah dibuat untuk kegiatan pelayanan laundry harus ditaati, tidak ada kesalahan pemberian bahan chemical, pencucian yang bersih sehingga pasien merasa nyaman dan bebas dari efek samping yang ditimbulkan dari pengelolaan linen yang tidak benar.

6.2 Tujuan

Memenuhi standar keselamatan pasien melalui pemakaian linen oleh pasien tanpa menimbulkan efek samping yang ditimbulkan dari pengelolaan linen yang tidak benar.

6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien

Langkah-langkah penerapan keselamatan pasien rumah sakit

- a. Mulai dengan membuat standar prosedur operasional (SPO).
- b. Melakukan SPO di semua segi pelayanan laundry.
- c. Mencatat dan menuliskan laporan kejadian bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan (KTD).
- d. Kepala Instalasi bersama pihak yang terkait melakukan penyelidikan terhadap KTD, mencari jalan keluar bila perlu merubah system sehingga lebih baik dan lebih aman untuk pasien, membuat tindak lanjut dan mensosialisasikan tindak lanjut untuk dilakukan bersama dan mengevaluasi system yang baru tersebut.
- e. Melaporkan Indikator keselamatan pasien setiap bulan dalam rapat kerja bulanan dengan direksi yaitu :
 - Kejadian yang berhubungan dengan efek samping yang ditimbulkan dari pengelolaan linen
 - Kejadian yang berhubungan dengan standar pengendalian infeksi (cuci tangan)
- f. Melakukan semua standar pengendalian infeksi.
- g. Memilih chemical yang bermutu dan aman bagi linen yang dipakai pasien.

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

7.1 Pengertian

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman , sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerjadan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) dikalangan petugas kesehatan belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju dari beberapa pengamatan menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab adalah kurangnya kesadaran pekerja, serta kualitas ketrampilan pekerja yang kurang memadai, sehingga meremehkan resiko kerja, contohnya tidak menggunakan APD pada saat pengolahan linen kotor.

7.2 Tujuan

Terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja di unit laundry agar tercapai pelayanan dan produktivitas kerja yang optimal.

7.3 Potensi Bahaya Pada Unit Laundry

1. Bahaya Mikrobiologi

Bahaya mikrobiologi adlaah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh mikroorganisme hidup seperti bakteri, virus, parasit dan jamur. Pentugas laundry yang menangani linen kotor senantiasa kontak dengan bahan dan menhirup udara yang tercemar kuman pathogen. Penelitian bakteriologis pada instalasi laundry menunjukan bahwa jumlah total bakteri meningkat 50 kaliselama periode waktu sebelum cucian mulai diproses.

Mikroorganisme tersebut aadalah :

a. *Severe acute respiratori syndrome coronavirus (SARS-COV 19)*

- Adalah mikroorganisme penyebab Covid 19 dan paling sering menyerang pernapasan infeksi paru berat hingga kematian..Penularannya melalui percikan atau dahak penderita melalui lubang mata, hidung dan mulut. Pencegahan :
 1. Meningkatkan pengertian dan kepedulian petugas rumah sakitterhadap penyakit TBC dan penularannya.
 2. Mengupayakan ventilasi dan pencahayan yang baik dalam ruangan instalasi laundry.
 3. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan SPO.
 4. Melakukan tindakan dekontaminasi, desinfeksi dan sterilisasiterhadap bahan dan lat yang digunakan.
 5. Secara teknis setiap petugas harus melaksanakan tugas pekerjansesuai SPO.

b. Virus hepatitis B

- Selain manifestasi sebagai hepatitis B akut dengan segal komplikasi, lebih penting dan lebih berbaya lagi adalah inamifestasi dalam bentuk

sebagai pengidap(carrier) kronik, yang dapat merupakan sumberpenularan bagi lingkungan.

- Penularan dapat melalui darah dan cairan tubuh lainnya.
- Pencegahan :
 1. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian petugas rumah sakit terhadap penyakit hepatitis B dan penularannya.
 2. Memberikan vaksinasi pada petugas
 3. Menggunakan APD sesuai dengan SPO.
 4. Melakukan tindakan dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi terhadap bahan dan peralatan yang dipergunakan terutama jika terkena bahan infeksi.
 5. Secara teknis setiap petugas harus melaksanakan tugas pekerjaan sesuai SPO.

c. Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)

- Penyakit yang ditimbulkannya disebut AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Virus HIV menyerang target sel dalam jangka waktu lama. Jarak waktu masuknya virus ke tubuh sampai timbulnya AIDS tergantung pada daya tahan tubuh seseorang dan gaya hidupnya.
- HIV dapat hidup di dalam darah, cairan vagina, cairan sperma, air susu ibu, secreta dan esktreta tubuh.
- Penulannya melalui darah, jaringan, secreta, ekstreta tubuh yang mengandung virus dan kontak langsung dengan kulit yang terluka.
- Pencegahan :
 1. Linen yang terkotaminasi berat ditempatkan pada kantong plstik keras yang berisi desinfektan, berlapis ganda, tahan tusukan, kedap air dan berwarna khusus serta di berikan label bahan menular/AIDS selajutnya dibakar.
 2. Menggunakan APD sesiai dengan SPO

2. Bahaya Debu

Pada instalasi linen debu dapat terasa dari bahn linen itu sendiri

- Efek kesehatan
Mekasime penimbunan debu dalam paru-paru dapat terjadi dengan menarik nafas sehingga udara yang mangadung debu masuk ke dalam paru-paru.
- Pengendalian
 - a. Pencegahan tehdap sumber
Diusahkan agar debu tidak keluar dari sumbernya dengan mengisolasi sumber debu
 - b. Memakai APD sesuai SPO.
 - c. Ventilasi yang baik
 - d. Dengan alt local ekshauster

3. Bahaya Bahan Kimia

Sebahian besar dari bahaya di instalasi laundry di akibatkan oleh zat kimia seperti detergen, desinfektan, zat penutih dan lain-lain. Tingkat resiko yang di akibatkan tergantung dari besar dan luas

Penanganan zat-zat kimia di instalasi pencucian:

a. Alkali

Guna : bubuk penambah alkali

Cirri-ciri khusus : bubuk kekuningan dengan Ph 12,0 sampai 13,0

Sifat : bila terkena panas akan terkomposisi menjadi gas yang mungkin

beracun dan iritasi, tidak mudah terbakar.

Bahaya kesehatan :

- Iritasi mata, iritasi kulit
- Bila terhirup menyebabkan edema paru.
- Bila tertelan menyebabkan kerusan hebat pada selaput lendir

Pertolongan pertama :

- Mata : cuci secepatnya dengan air banyak-banyak.
- Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang tidak terkontaminasi.
- Terhirup : pindahkan dari sumber
- Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air atau susu

Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda.

Tindakan pencegahan :

- Control teknis, gunakan ventilasi setempat, peralatan penafasan sendiri.
- Memakai APD.
- Penyimpanan : simpan pada tempat aslinya, wadah tertutup, dibawah kondisi kering, ventilasi yang baik, jauhkan dari asam dan hindarkan dari suhu ekstrim

b. Detergen

Guna : detergen laundry bubuk.

Cirri-ciri khusus : serbuk putih berwarna biru dengan pH 11.0-12,0.

Sifat : bila terkena panas akan terkomposisi menjadi gas yang mungkin beracun dan iritasi, tidak mudah terbakar.

Bahaya kesehatan :

- Iritasi mata, iritasi kulit.
- Bila terhirup : menyebabkan edema paru
- Bila tertelan : menyebabkan kerusakan selaput lendir

Pertolongan pertama :

- Mata : cuci secepatnya dengan air banyak-banyak.
- Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang tidak terkontaminasi.
- Terhirup : pindahkan dari sumber
- Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air atau susu

Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda.

Tindakan pencegahan :

- Control teknis, gunakan ventilasi setempat, peralatan penafasan sendiri.
- Memakai APD.
- Penyimpanan : simpan pada tempat aslinya, wadah tertutup, dibawah kondisi kering, ventilasi yang baik, jauhkan dari asam dan hindarkan dari suhu ekstrim.

c. Emulsifier

Guna : cairan pengemulsi lemak/minyak dan prespotter

Cirri-ciri umum : larutan bening, tidak berwarna, kental, pH 10,0-11,0.

Sifat : rusak oleh sinar matahari, stabil dan tidak mudah terbakar.

Bahaya kesehatan :

- Iritasi mata, iritasi kulit.
- Bila terhirup : menyebabkan iritasi
- Bila tertelan : menyebabkan iritasi

Pertolongan pertama :

- Mata : aliri dengan air selama 15 menit
- Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang tidak terkontaminasi.
- Terhirup : pindahkan dari sumber
- Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air. Jangan berusaha untuk muntah.

Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda.

Tindakan pencegahan :

- Control teknis, gunakan ventilasi setempat, peralatan penafasan sendiri.
- Memakai APD.

Penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering, jauhkan dari sinar matahari langsung, hindari sumber panas.

d. *Bleach* (oksigen *Bleach* dan *Chlorine Bleach*)

1. *Oksigen Bleach*

Guna : bubuk pemutih beroksigen

Ciri-ciri : bubuk putih dengan pH 10.0-11,0

Sifat : bereaksi dengan bahan-bahan pereduksi, tidak mudah terbakar, beracun untuk ikan (di larutkan dulu sebelum dibuang ke selokan atau sumber air)

Bahaya kesehatan :

- Iritasi berat pada mata, rasa terbakar pada kulit
- Bila terhirup menyebabkan iritasi, odema paru
- Bila tertelan menyebabkan rasa terbakar

Pertolongan pertama :

- Mata : cuci secepatnya dengan air banyak-banyak.
- Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang tidak terkontaminasi.
- Terhirup : pindahkan dari sumber
- Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air atau susu

Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda.

Tindakan pencegahan :

- Control teknis, gunakan ventilasi setempat, peralatan penafasan sendiri mungkin diperlukan untuk penggunaan yang lama.
- Memakai APD.

Penyimpanan : simpan pada tempat sejuk dan kering, jauhkan dari asam, hindari sumber panas.

2. *Chlorine Bleach*

Guna : bubuk pemutih berchlorin

Ciri-ciri khusus : bubuk putih dengan pH 8,0-9,0

Sifat : bereaksi dengan asam akan mengeluarkan keluarnya gas klorindengan cepat, tidak mudah terbakar

Bahaya kesehatan :

- Iritasi berat pada mata, rasa terbakar pada kulit
- Bila terhirup menyebabkan iritasi saluran nafas, asma, odema paru dan kanker paru
- Bila tertelan menyebabkan rasa terbakar

Pertolongan pertama :

- Mata : cuci secepatnya dengan air banyak-banyak.
- Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang tidak terkontaminasi.

- Terhirup : pindahkan dari sumber
 - Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air atau susu
- Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda.

Tindakan pencegahan :

- Kontrol teknis, gunakan ventilasi setempat, peralatan penafasan sendiri mungkin diperlukan untuk penggunaan yang lama.
- Memakai APD.

Penyimpanan : simpan pada tempat sejuk dan kering, jauhkan dari asam, hindari sumber panas.

e. Sour / Penetral

Guna : bubuk pengasam / penetralisir laundry

Cirri-ciri khusus : bubuk berwarna biru dengan pH 4,0-5,0

Sifat : bereaksi dengan asam akan mengeluarkan sulfur dioksida keluar, tidak mudah terbakar.

Bahaya kesehatan :

- Iritasi berat pada mata, iritasi pada kulit
- Bila terhirup menyebabkan iritasi
- Bila tertelan menyebabkan iritasi

Pertolongan pertama :

- Mata :cuci secepatnya dengan air
- Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang terkontaminasi
- Tehirup : pindahkan dari sumber
- Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air atau susu

Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda

Tindakan pencegahan :

- Control teknis, gunakan ventilasi setempat peralatan pernapasan sendiri mungkin diperlukan untuk penggunaan yang lama
- Memakai APD

Penyimpanan : simpan ditempat sejuk dan kering, jauhkan dari asam,hindari sumber panas

f. Softener

Guna : cairan pelunak dan pelembut kain

Cirri-ciri khusus : cairan merah muda, opak dan mudah mengalir, pH 4,0- 5,0

Sifat :stabil, tidak mengandung bahan berbahaya, tidak mudah terbakar

Bahaya kesehatan :

- Iritasi berat pada mata, iritasi pada kulit
 - Bila terhirup menyebabkan iritasi
 - Bila tertelan menyebabkan iritasi
- Pertolongan pertama :
- Mata : cuci secepatnya dengan air
 - Kulit : cuci kulit secepatnya dengan air, ganti pakaian yang terkontaminasi
 - Tehirup : pindahkan dari sumber
 - Tertelan : cuci mulut, minum satu atau dua gelas air atau susu

Pertolongan selanjutnya : dengan mencari pertolongan medis tanpa ditunda

Tindakan pencegahan :

- Kontrol teknis, gunakan ventilasi setempat peralatan pernapasan sendiri mungkin diperlukan untuk penggunaan yang lama

- Memakai APD

Penyimpanan : simpan ditempat sejuk dan kering, hindari suhu yang ekstrim

4. Kebakaran:

Kebakaran terjadi apabila terdapat tiga unsur bersama-sama. Unsur-unsur tersebut adalah zat asam , bahan yang mudah terbakar dan panas. Bahan yang mudah terbakar misalnya bahan yang ada pada mesin cuci.

a. Penanggulangan :

- Legislatif
- Mengacu pada UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- System penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar
- Pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran dilakukan secara terus menerus
- Perlengkapan pemadam dan penanggulangan kebakaran

5. Terpeleset / terjatuh

Terpeleset atau terjatuh pada lantai yang sama adalah bentuk kecelekaan kerja yang dapat terjadi pada instalasi laundry. Walaupun jarang terjadi kematiantetapi dapat mengakibatkan cedera yang berat seperti fraktura, dislokasi, salah urat, memar otak

Upaya pencegahan kecelakaan adalah dengan cara :

- Jangan memakai sepatu dengan sol yang rusak atau memakai tali sepatuyang longgar.
- Kontruksi lantai harus rata dan sedapat mungkin dibuat dari bahan yangtidak licin
- Pemeliharaan lantai
 - ✓ Lantai harus selalu dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti pasir, debu,minyak yang memudahkan terpeleset
 - ✓ Lantai yang cacat misalnya banyak lubang atau permukaanya miringharus segera diperbaiki
- Melaksanakan prosedur tetap.

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

8.1 Definisi Indikator

Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik.

8.2 Kriteria

Spesifikasi dari indikator.

8.3 Standart

Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik. Sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu.

Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan maka harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aspek yang dipilih untuk ditingkatkan
 - a. Keprofesian
 - b. Efisiensi
 - c. Keamanan pasien
 - d. Kepuasan pasien
 - e. Sarana dan lingkungan fisik
2. Indikator yang dipilih
 - a. Indikator lebih diutamakan untuk menilai output daripada input dan proses
 - b. Bersifat umum, yaitu lebih baik indikator untuk situasi dan kelompok daripada untuk perorangan
 - c. Dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah dan antar Rumah Sakit
 - d. Dapat mendorong intervensi sejak tahap awal pada aspek yang dipilih untuk dimonitor
 - e. Didasarkan pada data yang ada
3. Kriteria yang digunakan

Kriteria yang digunakan harus dapat diukur dan dihitung.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman pelayanan laundry mempunyai peranan penting untuk pedoman kerja bagi laundry dalam memberikan pelayanan pengelolaan dan pencucian linen untuk memenuhi kebutuhan pasien, sehingga mutu dan keselamatan pasien yang memakai linen RS dapat terjamin. Pedoman ini dapat digunakan juga sebagai acuan kerja bagi tenaga laundry.

Penyusunan pedoman pelayanan laundry ini adalah merupakan langkah awal sebagai suatu proses yang panjang sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan laundry dan tujuan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah